PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL POSITIVA PARA ADULTOS:

Manual de apoyo



AUTORES

Sónia Teixeira I Carlos Sequeira I Teresa Lluch

TÍTULO

Programa de promoción de la Salud Mental Positiva para adultos (Mentis Plus⁺): manual de apoyo.

FICHA TÉCNICA

AUTORES

SÓNIA TEIXEIRA

Doctoranda en Enfermería y Salud en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanha)

Asistente invitada en la Escola Superior de Enfermagem do Porto

Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria no Hospital Magalhães Lemos E.P.E (Portugal)

CARLOS SEQUEIRA

Doctor en Ciências de Enfermagem

Profesor en la Escola Superior de Enfermagem do Porto (Portugal)

TERESA LLUCH

Doctora en Psicología. Catedrática de Enfermería Psicosocial y Salud Mental.

Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil.

Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Barcelona (España).

TRADUCTORES

SUSANA MANTAS JIMÉNEZ

Enfermera, Psicóloga. Doctora por la Universidad de Girona.
Profesora Investigadora en el Departamento de Enfermería. Universidad de Girona.

CARME FERRÉ GRAU

Enfermera, Psicóloga y Doctora en Antropología de la Salud.
Profesora Titular del Departamento de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili.

Referencia versión original-portugués: Teixeira, S., Sequeira, C. & Lluch, T. (2020). Programa de promoção de Saúde Mental Positiva para adultos (Mentis Plus⁺): manual de apoio. Porto: A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. ISBN 978-989-54826-0-3

Referencia versión castellano: Teixeira, S., Sequeira, C. & Lluch, T. (2021). Programa de promoción de la Salud Mental Positiva para adultos (Mentis Plus⁺): manual de apoyo. Barcelona: Universitat de Barcelona, Deposito Digital, Colección OMADO. (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2)



SAÚDE MENTAL+

“The absence of mental illness is not a suficient indicator of mental health”

Marie Jahoda

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN 11

PARTE I – SALUD MENTAL POSITIVA 13

1. **Concepto de Salud Mental Positiva** 15

1.1. **Evolución histórica de la Salud Mental Positiva** 16

2. **Modelo Multifatorial de Salud Mental Positiva** 17

2.1. **Cuestionario de Salud Mental Positiva** 19

2.1.1. **Interpretación del Cuestionario de Salud Mental Positiva** 20

2.2. **Decálogo de Salud Mental Positiva** 22

PARTE II – PROGRAMA DE SALUD MENTAL POSITIVA PARA ADULTOS 23

3. **OBJETIVO GENERAL** 25

4. **ESTRUTURA** 26

PARTE III – SESIONES DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL POSITIVA 29

5. **SESIÓN INICIAL** 31

6. **PRIMERA SESIÓN** 34

7. SESIONES DEL FACTOR: SATISFACCIÓN PERSONAL (F1) 35

7.1. **SESIÓN F1 A** 35

7.2. **SESIÓN F1 B** 35

7.3. **SESIÓN F1 C** 36

8. SESIONES DEL FACTOR: ACTITUD PROSOCIAL (F2) 37

8.1. **SESIÓN F2 A** 37

8.2. **SESIÓN F2 B** 37

8.3. **SESIÓN F2 C** 38

9. SESIONES DEL FACTOR: AUTOCONTROL (F3) 39

9.1. **SESIÓN F3 A** 39

9.2. **SESIÓN F3 B** 40

9.3. **SESIÓN F3 C** 41

10. SESIONES DEL FACTOR: AUTONOMÍA (F4) 42

10.1. **SESIÓN F4 A** 42

10.2. **SESIÓN F4 B** 43

10.3. **SESIÓN F4 C** 44

11. SESIONES DEL FACTOR: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AUTOACTUALIZACIÓN (F5) .. 45

11.1. **SESIÓN F5 A** 45

11.2. **SESIÓN F5 B** 46

11.3. **SESIÓN F5 C** 47

12. SESIONES DEL FACTOR: HABILIDADES DE RELACIÓN INTERPERSONAL (F6) 47

12.1. **SESIÓN F6 A** 47

12.2. **SESIÓN F6 B** 48

12.3. **SESIÓN F6 C** 48

13. SESIÓN FINAL 49

14. SESIÓN DE SEGUIMIENTO 49

BIBLIOGRAFIA 51

ANEXOS 55

Anexo I – Consentimiento informado

Anexo II – Cuestionario sociodemográfico

Anexo III – Cuestionario de Salud Mental Positiva (Lluch, 1999)

INTRODUCCIÓN

El manual que se presenta a continuación es la versión traducida al español del manual original en versión portuguesa denominado *Mentis Plus +,* cuya finalidad es servir de guía para todos los profesionales de la salud formados en el área de la salud mental y la psiquiatría, concretamente profesionales de la enfermería especialistas en salud mental y psiquiatría. El objetivo es la aplicación de un programa de salud mental para promover la salud mental positiva en la población española.

La salud mental positiva se entiende como la salud mental de las personas sanas construida sobre la optimización del bienestar general. En este sentido, nos pareció adecuado elaborar la traducción del programa original de promoción de la salud mental positiva en adultos para la población española, ya que no existen programas estructurados y validados en España en esta área.

El Programa de Salud Mental Positiva surge para superar la necesidad de implementar la promoción en el ámbito de la Salud Mental a través de un modelo integrado en sesiones, que puede ser dinamizado por los profesionales de la salud de manera sistemática, mediante procedimientos estandarizados ajustados a las necesidades individuales de la comunidad / usuario/-s.

La OMS (2020) considera que el personal de enfermería desempeña una función crucial en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a proporcionar los cuidados y satisfacer las necesidades asistenciales esenciales del día a día, en todas las etapas evolutivas de la población. Asimismo, las enfermeras/-os de salud mental son los profesionales de la salud en España que constituyen el mayor potencial en cuánto a la atención y apoyo a la población se refiere.

Por ello, es de suma importancia diseñar un programa de intervención que sirva de matriz para que los profesionales de la salud, concretamente el personal de enfermería promueva la Salud Mental Positiva (SMP), en la población adulta. La elaboración de este programa fue el resultado de una revisión sistemática de la literatura sobre el tema, realizada en 2017 y del trabajo conjunto de reuniones con expertos (focus group) en el año 2018.

Se propone un Programa de Salud Mental Positiva para adultos basado en el Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva de Lluch, (Lluch, 1999) donde se pueden trabajar los seis factores que configuran el Modelo: F1-Satisfacción Personal; F2-Actitud prosocial; F3-Autocontrol; F4-Autonomía; F5-Resolución de problemas y autoactualización y F6-Habilidades de relación interpersonal.

El programa tiene una duración mínima de 7 semanas (1 sesión por semana, de 1 hora de duración) y se puede trabajar individualmente o en grupos (6-12 personas). Habrá 2 sesiones iniciales de 1 hora cada una y 3 sesiones por cada factor/dimensión a trabajar con una duración de 1 hora.

El objetivo es lograr y garantizar avances en el área de Salud Mental Positiva en la población española, así como su seguimiento efectivo a través del Cuestionario de Salud Mental Positiva (ya validado en Portugal).

1ªPARTE

SALUD MENTAL POSITIVA

SALUD MENTAL POSITIVA

Según Xavier, Baptista, Mendes, Magalhães y Caldas-de-Almeida (2013), las enfermedades y los trastornos mentales se han convertido en los últimos años en la principal causa de discapacidad y una de las principales causas de morbilidad en la población. En España, las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las enfermedades del sistema respiratorio, sistema nervioso y de los órganos de los sentidos y, en quinto lugar los trastornos mentales y del comportamiento constituyen las principales causas de muerte entre la población (INE,2018). De acuerdo con las estadísticas, es prioritario el diseño de programas con el objetivo de fortalecer la salud de la población, concretamente, fortalecer la salud mental de las personas aumentando así su calidad de vida y bienestar.

1. Concepto de salud mental positiva

La promoción de la salud mental a menudo engloba la salud mental positiva, considerándola como un recurso y un valor en sí mismo, por lo tanto, un derecho humano básico crucial para el desarrollo social y económico. La salud mental positiva subyace como un elemento eficaz de protección contra las enfermedades mentales (OMS, 2001).

Cabe aclarar que la salud mental es una entidad propia y la salud mental positiva es un segmento específico en ella, siendo producto de varios factores (Lluch, 2008), como se ilustra en la figura 1.

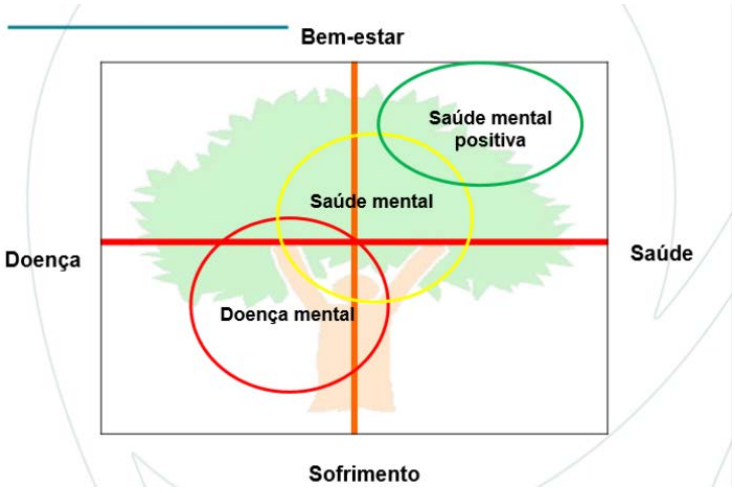


Figura 1 – Salud Mental Positiva como segmento específico (Sequeira & Lluch,2015)

En esta línea, la salud mental positiva se entiende como la salud mental de las personas sanas construida sobre la optimización del bienestar general en el transcurso de las transiciones dinámicas a lo largo de la vida.

El concepto de salud mental positiva se utiliza para describir algo más que ausencia de enfermedad, es un término dirigido y dedicado especialmente a la promoción de la salud mental en una perspectiva de fortalecimiento y desarrollo del funcionamiento óptimo del ser humano.

Según Lluch (2008) es importante saber que la salud mental positiva:

a) No siempre se trata de ser feliz y estar contento

b) Es mantener la atracción por un mundo ideal, integrando el sentido de la realidad de la vida: nacemos, vivimos y morimos en un ciclo vital altamente complejo y como seres humanos estamos dotados de sentimientos positivos y negativos

c) Salud mental positiva es poder estar triste en momentos tristes, manteniendo la capacidad de funcionamiento social e individual

d) Es un concepto que está totalmente inmerso en la promoción de la salud mental y que puede incluirse en el marco de "la psicología de la vida cotidiana"

e) Es una construcción

Sin embargo, tanto la salud física como la mental son estados dinámicos, fuertemente interconectados y con fluctuaciones a lo largo del ciclo de vida.

1.1. **Evolución histórica de la Salud Mental Positiva**

Marie Jahoda desarrolló el concepto de salud mental positiva en su monografía *Current concepts of positive mental health* (Jahoda, 1958), proporcionando importantes indicadores para la construcción de nuevas leyes en la sociedad estadounidense en el contexto de la promoción de la salud mental. Posteriormente en Europa, los conceptos formulados por Jahoda sirvieron de base para que Maria Teresa Lluch Canut (1999) en el intento de operativizar los planteamientos conceptuales y evaluar la Salud Mental Positiva, desarrollara un Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva. Así, Lluch definió el Modelo Multifactorial de SMP a partir de 6 factores y construyó el Cuestionario de Salud Mental Positiva (Lluch,1999).

El Cuestionario de Salud Mental Positiva desarrollado originalmente en España fue posteriormente validado en Portugal por Sequeira et al. en 2014 (Figura 2).

La validación del cuestionario en Portugal se produjo como consecuencia de la conceptualización del término de SMP a través del Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva y la monitorización de la Salud Mental Positiva a través del Cuestionario de Salud Mental Positiva.

Posteriormente, el estudio se enfocó en promover la salud mental positiva a partir de programas con la capacidad de identificar el concepto, es decir, sensibles a las características positivas de la salud mental en la población de referencia (Figura 2).

Asimismo, y como parte fundamental del proceso, es necesario evaluar la efectividad de programas de salud mental positiva, como el que se presenta en este manual dirigido a adultos.

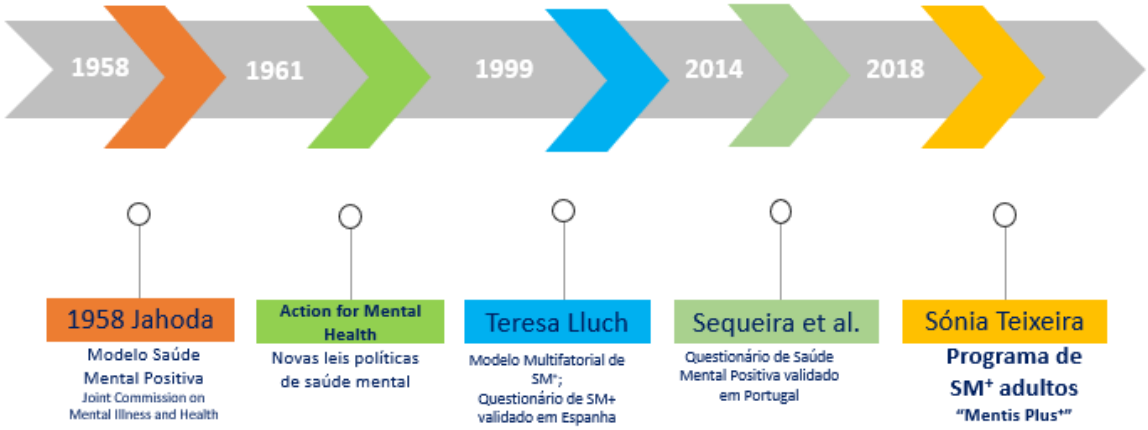


Fig. 2 – Diagrama histórico de Salud Mental Positiva

2. MODELO MULTIFATORIAL DE SALUD MENTAL POSITIVA

El Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva desarrollado por Lluch en 1999 como resultado de su tesis doctoral se basa en seis factores (Figura 3), algo diferente a los criterios iniciales planteados por Jahoda (1958).

Estos factores son los siguientes: Satisfacción personal (F1), Actitud prosocial (F2), Autocontrol (F3), Autonomía (F4), Resolución de problemas y autoactualización (F5) y Habilidades de relación interpersonal (F6) (Lluch , 1999, 2003).

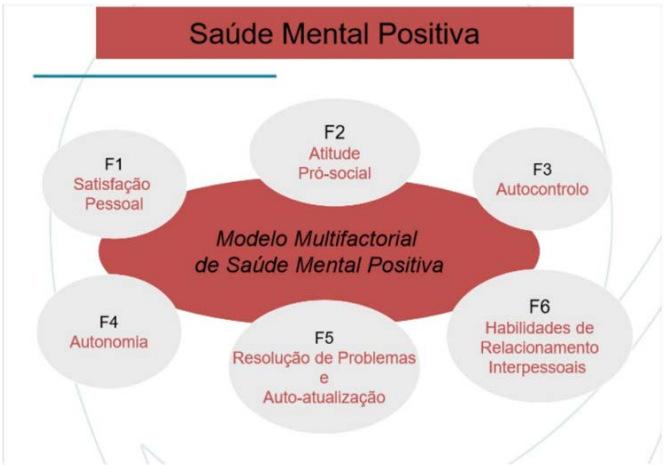


Figura 3 – Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva de Lluch (LLuch, 1999, 2020; Sequeira & Lluch,2015; Lluch-Canut, Sequeira & Roldán-Merino, 2017)

La definición de Salud Mental Positiva basada en este modelo se basa en los siguientes supuestos fundamentales:

1. Se entiende como un constructo y significa que no se puede definir directamente; se necesitan términos más específicos, como factores o dimensiones.

2. Se entiende como un estado dinámico y flotante. La concepción dinámica de la salud mental positiva implica aceptar sentimientos y experiencias tanto positivas como negativas.

3. Tiene límites que deben controlarse. Todos los estados emocionales tienen límites que, si se superan (por déficit o en exceso), pueden provocar patología.

4. Los factores que componen el Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva están interrelacionados, de modo que unos puedan compensar a otros. Así, según el momento o la situación personal, unos factores prevalecen sobre otros (Lluch, 1999, 2002, 2003, 2008, 2020; Lluch-Canut, Sequeira, & Roldán-Merino, 2017).

A continuación, en la Tabla 1, se describen los aspectos conceptuales más relevantes que definen cada uno de los seis factores.

Tabla 1 - Definición de los factores del Modelo de Salud Mental Positiva (Lluch, 1999, 2020; Sequeira & Lluch, 2015; Lluch-Canut, Sequeira, & Roldán-Merino, 2017)

Factores	Definición de los factores
F1-Satisfacción Personal	Se refiere a la satisfacción contigo mismo (autoconcepto/ autoestima), con tu vida personal y con las perspectivas de futuro.
F2-Actitud prosocial	Incluye la sensibilidad de una persona a su entorno social, la actitud y el deseo de ayudar y/o apoyar a los demás y la aceptación de los demás y de los hechos sociales diferenciales.
F3-Autocontrol	Contempla la capacidad de la persona para afrontar situaciones de estrés y conflicto, equilibrio emocional/control emocional y tolerancia a la ansiedad y al estrés.
F4-Autonomía	Incluye la capacidad de la persona para tomar sus propias decisiones aplicando sus propios criterios, autorregulando su propio comportamiento y manteniendo un buen nivel de seguridad personal/confianza en sí mismo.
F5-Resolución de Problemas y autoactualización	Se refiere a la capacidad de análisis de la persona, la habilidad para tomar decisiones así como la flexibilidad/capacidad para adaptarse a los cambios, desarrollando una actitud de crecimiento y desarrollo personal continuo.
F6: Habilidades de Relación Interpersonal	Incluye la capacidad de la persona para comunicarse y establecer relaciones interpersonales íntimas y la empatía/capacidad para entender los sentimientos de los demás. Es la habilidad para ofrecer apoyo emocional.

2.1. **Cuestionario de Salud Mental Positiva**

Los seis factores propuestos por Lluch (1999, 2003) en el Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva se evalúan a través del Cuestionario de Salud Mental Positiva con un total de 39 ítems que se distribuyen de manera desigual entre los 6 factores, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2 – Distribución por factores de los ítems del CSMP y valores máximos y mínimos de cada factor y del cuestionario global.

Factores	**Ítems***	**Valores máximos y mínimos**
F1-Satisfacción personal	4*,6,7,12,14,31,38 , 39	8-32
F2-Actitud prosocial	1,3,23*,25*,37*	5-20
F3-Autocontrol	2,5*,21*,22*,26*	5-20
F4-Autonomía	10,13,19,33,34	5/20
F5- Resolución de Problemas y autoactualización	15*,16*,17*,27*,28*,29*,32*,35*,36*	9-36
F6: Habilidades de Relación Interpersonal	8,9,11*,18*,20*,24,30	7-28
CSMP Total	1 al 39	39-156

*Indica los ítems positivos. Los ítems restantes están formulados en negativo. Adaptado de Lluch en Fornes y Gómez (2008).

2.1.1. **Interpretación del Cuestionario de Salud Mental Positiva**

Como ya se ha indicado, el Cuestionario de Salud Mental Positiva (CSMP) consta de 39 ítems. En el cuestionario de Salud Mental Positiva se pueden obtener valores entre 39 (valor mínimo) y 156 (valor máximo), y cuanto mayor es el valor obtenido, mayor es el nivel de salud mental positiva. Por lo tanto, es posible categorizar diferentes niveles de Salud Mental Positiva, como se muestra en la Tabla 3. Teóricamente, si adoptamos la propuesta de García (2016), se pueden establecer tres niveles de salud mental positiva. Serán necesarias escalas normativas para establecer los límites clínicos de muestras específicas. El CSMP permite obtener valores globales de SMP y por factores específicos (ver tablas 3 y 5).

Tabla 3 – Niveles de Salud Mental Positiva global (adaptado de García, 2016)

Niveles de Salud Mental Positiva	
Nivel Bajo o *languising*	Resultados entre 39-78
Nivel Medio	Resultados entre 79-117
Nivel Alto o *Flourising*	Resultados entre 118-156

Las respuestas a cada ítem se presentan en una escala Likert de 1 a 4, haciendo referencia a la frecuencia con la que ocurre cada afirmación en la vida del individuo (Tabla 4). Así, cada persona debe responder según la frecuencia que mejor se adapte a su caso: "Siempre o casi siempre", "La mayoría de las veces", "A veces" y "Rara vez o nunca".

De los 39 ítems que componen el cuestionario, 19 ítems están formulados mediante afirmaciones positivas y 20 ítems mediante afirmaciones negativas. Los ítems expresados positivamente son: 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37. Por lo tanto, de acuerdo con el enunciado del ítem, formulado de forma negativa o positiva, las respuestas presentadas en la escala Likert tendrán puntuaciones o valores diferentes (Lluch 1999, 2003; Sequeira et al. 2014).

Tabla 4 – Puntuación de las respuestas sobre ítems positivos y negativos en el CSMP

RESPUESTA	**ÍTEMS POSITIVOS**	**ÍTEMS NEGATIVOS**
“Siempre o casi siempre”	4	1
“Bastante frecuente”	3	2
“Algunas veces”	2	3
“Nunca o casi nunca”	1	4

Así, obtener valores más altos en la suma global del CSMP estará relacionado con niveles más altos de SMP (el límite superior es 156), mientras que obtener valores más bajos se traduce en niveles más bajos de SMP (límite inferior es 39), (Tabla 3). Lo mismo ocurre con la puntuación para cada uno de los factores, obteniendo valores específicos para cada factor. Así, se entiende que la puntuación obtenida en el CSMP es directamente proporcional a los niveles de SMP, es decir, a mayor puntuación mayor SMP.

Después de aplicar el CSMP, la interpretación de los resultados sobre la Puntuación Total (PT) y la Puntuación por Factor (PxF) pueden verse en la tabla 5.

De esta forma, es posible obtener indicadores acerca del nivel de salud mental positiva en el que se encuentra la persona y sobre qué factor/-es se puede trabajar y/o reforzar.

Tabla 5 – Interpretación de las puntuaciones del CSMP, global y por factores.

	Factores					
Ítems	F1	F2	F3	F4	F5	F6
	4*	1	2	10	15*	8
	6	3	5*	13	16*	9
	7	23*	21*	19	17*	11*
	12	25*	22*	33	27*	18*
	14	37*	26*	34	28*	20*
	31				29*	24
	38				32*	30
	39				35*	
					36*	
Puntuación mínima/ máxima	8/32	5/20	5/20	5/20	9/36	7/28
Niveles de puntuación por Factor (F1-F6)	Bajo 8-16 Medio 17-24 Alto 25-32	Bajo 5-10 Medio 11-15 Alto 16-20	Bajo 5-10 Medio 11-15 Alto 16-20	Bajo 5-10 Medio 11-15 Alto 16-20	Bajo 9-18 Medio 19-27 Alto 28-36	Bajo 7-14 Medio 15-21 Alto 22-28
Total clasificado	———	———	———	———	———	———
Total ítems	39/156					
Total clasificado	———					
Niveles de puntuación sobre PT	Nivel Bajo 39-7 Nivel Medio 79-117 Nivel Alto 118-156					

Nota. F1: Satisfacción personal; F2: Actitud prosocial; F3: Autocontrol; F4: Autonomía; F5: Resolución de Problemas y autoactualización; F6: Habilidades de Relación interpersonal.

*ítems formulados mediante afirmaciones positivas. Para su corrección, los ítems formulados mediante afirmaciones negativas deberán ser invertidos.

2.2. **Decálogo de Salud Mental Positiva**

Con el fin de reforzar la Salud Mental Positiva en la vida personal y concretar de forma más operativa los factores conceptuales del Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva Maria Teresa Lluch Canut (2011) definió un decálogo de 10 recomendaciones esenciales, que más tarde fueron traducidas al portugués por Sequeira.

1. Valorar positivamente las cosas buenas que tenemos en nuestra vida.
2. Poner cariño a las actividades de la vida cotidiana. La felicidad está entre nosotros escondida en el día a día. No hay que afrontar cada actividad cotidiana (coger el metro, comprar, trabajar, ...) como un castigo o con indiferencia. Hay que buscar los aspectos positivos de esas actividades y ponerles un estado de ánimo favorable.
3. No ser muy severos con nosotros mismos ni con los demás. La tolerancia, la comprensión y la flexibilidad son buenos tónicos para la salud mental.
4. No dejar que las emociones negativas bloqueen nuestra vida: hay que enfadarse pero no desbordarse.
5. Tomar conciencia de los buenos momentos que pasan en nuestra vida cuando están pasando. Si en nuestra vida hay buenos momentos para recordar estos tienen que haber sido buenos momentos cuando los hemos vivido. Por tanto hay que disfrutar de lo bueno del presente, además de recordar lo bueno del pasado y esperar cosas buenas del futuro.
6. No tener miedo de llorar y sentir. Hay que interpretar la normalidad de nuestros sentimientos: si hemos tenido un desengaño es normal sentir desencanto, si hemos perdido un ser querido es normal- es saludable mentalmente- sentir tristeza,...Ahora bien, si los estados emocionales son muy intensos, persistentes o incapacitantes hay que pedir ayuda profesional.
7. Buscar espacios y actividades para relajarnos mentalmente. Cada uno tiene sus propios gustos, recursos y estrategias (pasear, leer, practicar jardinería, no hacer nada, hablar con los amigos...).
8. Intentar ir resolviendo los problemas que nos vayan surgiendo. Si los problemas se acumulan, la salud mental tiembla!!! No todos los problemas tienen buenas soluciones pero hay que intentar siempre hacer algo para aliviarlos. Es la predisposición activa hacia la búsqueda de solución.
9. Cuidar nuestras relaciones interpersonales. Hablemos con nuestros seres queridos, visitemos a nuestros amigos, compartamos alguna tertulia con nuestros compañeros, vecinos, etc
10. NO HAY QUE OLVIDARSE DE PINTAR LA VIDA CON HUMOR PARA QUE ESTA TENGA MAS COLOR.

2ªPARTE

PROGRAMA DE SALUD MENTAL POSITIVA PARA ADULTOS

El Programa de Salud Mental Positiva “Mentis Plus +” es una implementación basada en el Modelo Multifatorial de Salud Mental Positiva de Teresa LLuch, constituido por 6 dimensiones/factores sobre los que se puede trabajar. A continuación, se ilustra en el siguiente diagrama:

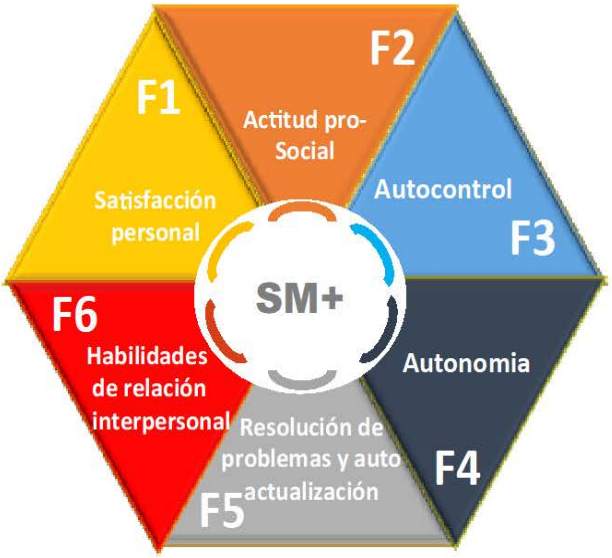


Figura 4 – Diagrama de los factores que configuran el programa de Salud Mental Positiva

3. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este programa es promover la salud mental positiva en adultos en diferentes contextos. Su construcción fue el resultado de una revisión sistemática de la literatura sobre el tema, realizada en 2017 “La efectividad de los programas de salud mental positiva en adultos: una revisión sistemática” (Teixeira, Coelho, Sequeira, Lluch-Canut, & Ferré-Grau, 2019).La revisión sistemática realizada, reveló que no existe un programa de promoción de la salud mental positiva que pueda ser aplicado de forma sistemática, es decir, de la misma manera por diferentes profesionales de la salud, a pesar de la evidencia de mejoras en la salud de quienes participan. De ahí surge la creación de Mentis Plus +, Programa de Salud Mental Positiva para adultos (figura 4). Posteriormente en 2018, se realizó la validación conceptual y estructural a través de un grupo focal (Teixeira, Sequeira, Ferré-Grau, & Lluch, 2020).

Este programa puede ser aplicado por profesionales de la salud capacitados en el área de Salud Mental Positiva, especialmente enfermeros especialistas en salud mental y psiquiatría.

4. ESTRUCTURA

El Programa de Salud Mental Positiva para adultos está organizado por factores, con un color asignado para cada factor (Figura 5).

Cada factor/dimensión se puede considerar un módulo, por lo que se considera un programa modular, que se puede aplicar por factores. Cada módulo consta de 3 sesiones para realizar en su totalidad.

Los módulos para trabajar corresponden a los factores identificados previamente con menor puntuación, tras la aplicación del cuestionario de salud mental positiva.

Participantes del programa:

- Personas adultas de ambos sexos, con edad igual o superior a los 18 años, que desarrollen su actividad profesional en diferentes contextos.

Criterios de inclusión:

- Personas sin antecedentes de diagnóstico de patología psiquiátrica.
- Personas que, habiendo firmado el consentimiento informado, manifiestan participar en el programa de manera libre y voluntaria.
- Personas vulnerables en uno o más factores / dimensiones del cuestionario de Salud Mental Positiva aplicado previamente.

Criterios de exclusión:

- No tener conocimientos suficientes para una comunicación fluida en lengua española.

El programa tiene una duración mínima de 7 semanas y máxima de 22 semanas (1 sesión por semana de 1 hora de duración).

La duración del programa depende de un individuo a otro. Es decir, depende de la cantidad de factores / módulos a trabajar.

Es un programa sistemático, por lo que el orden de las sesiones está regulado por las letras A, B y C para cada factor / módulo.

El programa se puede trabajar individualmente o en grupo (máximo entre 2 - 12 personas).

Desde que se aplica e interpreta el Cuestionario de Salud Mental Positiva CSMP, se pueden ir constituyendo los grupos de individuos que cuyas puntuaciones se sitúan en el mismo factor / módulo

a trabajar. Así, es posible determinar un grupo de un máximo de 12 personas para llevar a cabo las sesiones para cada factor / módulo en cuestión.

Habrá 2 sesiones iniciales de 1 hora cada una. Habrá 3 sesiones (A, B, C) por cada factor / dimensión a trabajar, con una duración mínima de 1 hora. Finalmente, se establecerá una sesión final y una sesión de seguimiento (3-6 meses después del programa).

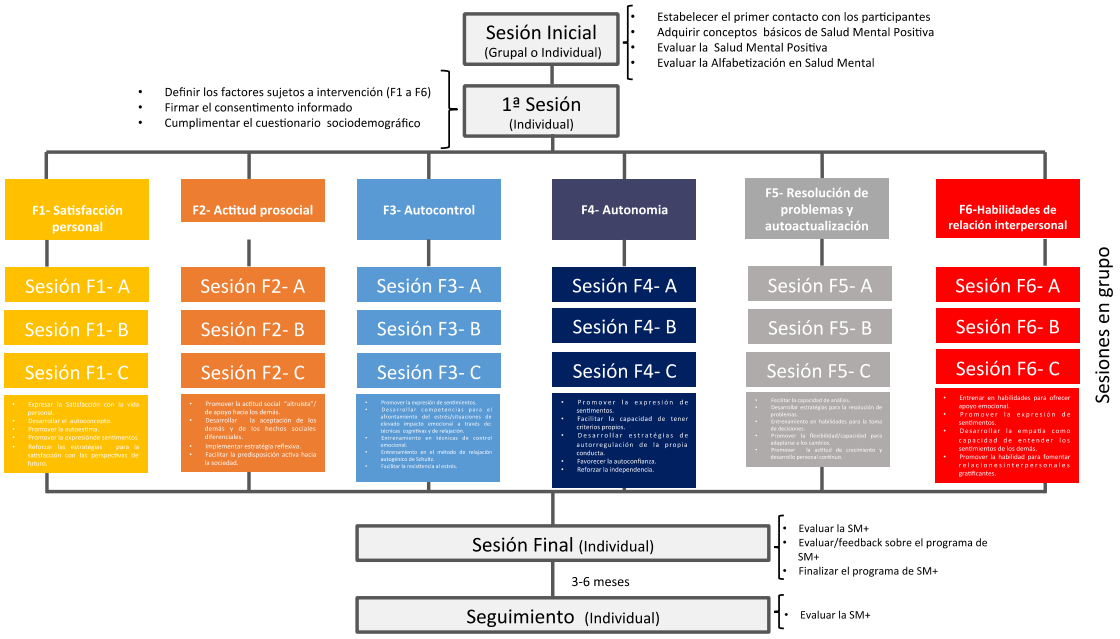


Figura 5 – Esquema del Programa de Salud Mental Positiva "Mentis PLus+"

Se incluirá a los participantes en función del entorno y/o contexto profesional. El objetivo de la sesión inicial del programa es establecer el primer contacto con los participantes según el entorno y/o contexto profesional, puede ser en grupo o individual (profesionales de enfermería en el centro de salud, grupos escolares vinculados a los respectivos centros educativos de referencia, etc.), informar/enseñar a la población de estudio acerca de los conceptos básicos de Salud Mental Positiva a través de una sesión de educación para la salud donde se presenta el Programa de Salud Mental Positiva. Posteriormente y siguiendo con los objetivos del programa, se tratará de evaluar la salud mental positiva y la alfabetización en salud mediante los respectivos cuestionarios e invitar a participar en el programa presentado mediante la programación de la 1ª sesión.

Así, en la sesión inicial se solicitará al participante que firme voluntariamente el consentimiento informado antes de iniciar cualquier procedimiento y que complete el cuestionario de datos sociodemográficos.

Posteriormente, en la 1ª sesión, se informa a los participantes de manera individual de los resultados obtenidos en el Cuestionario de Salud Mental Positiva, definiendo de forma conjunta el

factor/-es a trabajar/intervenir (F1 a F6). Luego, se programa la 2ª sesión según el factor (F1 a F6) a trabajar, y así sucesivamente hasta la última sesión del programa. Finalmente, en la sesión de denominada de seguimiento se volverán a aplicar los cuestionarios antes mencionados. Habrá un grupo de control y un grupo experimental. El grupo de control estará temporalmente sin la intervención, quedando sujeto al programa posteriormente. Es decir, el grupo de control participará en la sesión inicial que funciona como sesión de educación en salud y posteriormente en la sesión de seguimiento, donde se evaluará nuevamente la salud mental positiva a través del Cuestionario de Salud Mental Positiva.

La efectividad del programa aplicado se evaluará en la sesión final y en la sesión de seguimiento (3-6 meses después de finalizado el programa) mediante la aplicación del Cuestionario de Salud Mental Positiva.

3ªPARTE

SESIONES DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL POSITIVA

5. SESIÓN INICIAL

En esta sesión, se llevará a cabo una sesión de educación para la salud sobre los conceptos relacionados con la Salud Mental Positiva, donde se presenta el contenido y el programa respectivo que se implementará.

El cuestionario de salud mental positiva se aplicará en esta sesión, para que el investigador pueda interpretar posteriormente los resultados obtenidos.

Sesión Inicial (Grupal o Individual)

Objetivos:

- Establecer el primer contacto com los participantes.
- Adquirir conceptos básicos sobre Salud Mental Positiva.
- Evaluar la Salud Mental Positiva.
- Evaluar la Alfabetización en Salud Mental.

Material:

- Sala; Mesa; Sillas; Bolígrafos
- Cuestionario de SM+
- Cuestionario de Alfabetización en Salud Mental
- Fecha de presentación.

Procedimento:	
• Presentación de los participantes e investigadores.	5 min
• Presentación del Programa de SM+.	25 min
• Evaluar la salud mental positiva de los participantes: aplicar el cuestionario de SM+.	
• Evaluar la Alfabetización en Salud Mental Positiva: aplicar el cuestionario de Alfabetización en Salud Mental.	15 min
• Programación de la próxima sesión.	15 min

Notas:

La presentación del Programa de Salud Mental Positiva se puede realizar utilizando el video producido disponible a través del enlace https://youtu.be/817bdJUjw1g (versión original idioma portugués) o en PowerPoint usando las siguientes diapositivas:

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL POSITIVA

SAÚDE MENTAL+

Sónia Manuela Almeida Teixeira

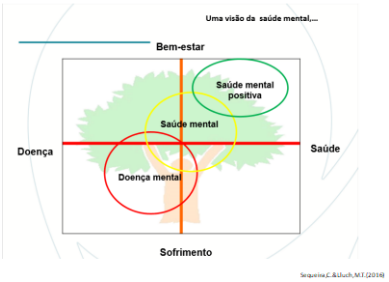


Según Xavier, Baptista, Mendes, Magalhães y Caldas-de-Almeida (2013), las enfermedades y los trastornos mentales se han convertido en los últimos años en la principal causa de discapacidad y una de las principales causas de morbilidad en la población.

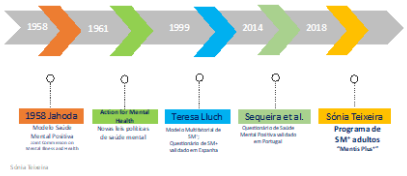




En España, las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las enfermedades del sistema respiratorio, sistema nervioso y de los órganos de los sentidos y, en quinto lugar los *trastornos mentales* y del comportamiento constituyen las principales causas de muerte entre la población (INE,2018).



Evolución histórica hacia el Programa de Salud Mental Positiva...



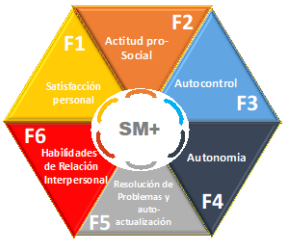
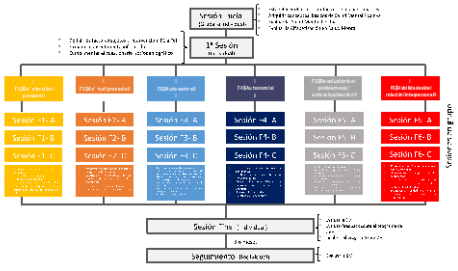


DIAGRAMA CIRCULAR SM+

SAÚDE MENTAL+

PROGRAMA [modular]DE SALUD MENTAL POSITIVA




SAÚDE MENTAL+
____Decálogo de Salud Mental Positiva___
(Jueh-Canut, M.T. 2013)
1. Valorar positivamente las cosas buenas que tenemos en nuestra vida.
2. Poner cariño a las actividades de la vida cotidiana.
3. No ser muy severos com nosotros mismos ni con los demás.
Sónia Teixeira
SAÚDE MENTAL+
4. No dejar que las emociones negativas bloqueen nuestra vida: hay que enfadarse pero no desbordarse.
5. Tomar conciencia de los buenos momentos que pasan en nuestra vida cuando están pasando.
6. No tener miedo de llorar y sentir. Hay que interpretar la normalidad de nuestros sentimentos.
Sónia Teixeira


SAÚDE MENTAL+
7. Buscar espacios y actividades para relajarnos mentalmente.
8. Intentar ir resolvendo los problemas que nos vayan surgiendo.
9. Cuidar nuestras relaciones interpersonales.
10. No hay que olvidarse de pintar la vida con humor para que esta tenga más color.
Sónia Teixeira
SAÚDE MENTAL+
¡Gracias por vuestra atención!
Autora: Sónia Teixeira

6. 1ª SESIÓN

En esta sesión el investigador informará al participante/-s acerca de los resultados e interpretación del Cuestionario de Salud Mental Positiva aplicado en la sesión anterior. Investigador y participante de forma conjunta, definirán los factores a mejorar/intervenir. Si el participante siente la necesidad de trabajar sobre un factor que no se define como vulnerable en la interpretación del CSMP, puede incluirlo en la intervención, ya que la autoconciencia es uno de los parámetros a tener en cuenta para la promoción de la salud mental positiva y de forma progresiva obtener mejoras en la salud mental.

Los participantes se pueden unir en grupos para las próximas sesiones según los factores a trabajar y según disponibilidad. La situación óptima es programar una sesión por semana y trabajar un solo factor, empezando con un segundo factor (si fuera necesario según la interpretación del CSMP cuando finalicen las 3 sesiones (A, B, C) estipuladas).

1ª Sesión (Individual)

Objetivos:	**Procedimento:**	
• Identificar cuáles son los fatores a trabajar en la Salud Mental Positiva (F1 a F6) • Definir los factores a intervenir • Firmar el consentimiento informado • Cumplimentar los cuestionarios de datos sociodemográficos de los participantes	• Bienvenida.	10 min
	• Informar a los participantes de los factores que van a ser trabajados durante las próximas sesiones.	20 min
	• Firma del consentimiento libre e informado. • Evaluación inicial y clasificación de los participantes a través del cuestionario de datos sociodemográficos.	15 min
Material: • Sala; Mesa; Sillas; Bolígrafos • Documento de consentimiento libre e informado • Cuestionario de datos sociodemográficos	• Programación de la próxima sesión.	15 min

Nota:

El modelo de consentimiento informado así como el cuestionario sociodemográfico se pueden consultar en el anexo de este manual.

7. SESIONES DEL FACTOR: F1- SATISFACCIÓN PERSONAL

7.1. Sesión F1-A

F1- Satisfacción Personal

1ª Sesión | **Sesión F1- A**

Objetivos:

- Manifestar satisfacción con la propia vida
- Desarrollar el autoconcepto
- Promover la interacción grupal
- Promover la autoestima y el autoconcepto
- Promover la expresión de sentimientos
- Adoptar estratégias de autorreflexión

Material:

- sala
- Mesa
- Sillas
- Folios / 1 cuaderno
- Bolígrafos

Procedimento:

• Saludo de bienvenida y presentación del grupo	5 min
• Cada participante deberá redactar alguna de las intervenciones en emergencias de la que guarda un recuerdo positivo	20 min
• Compartirlo/leerlo en grupo • Se abre un espacio de discusión para explicar con qué emociones se asocian los recuerdos positivos • Tarea para casa: solicitar que cada persona escriba aquellas cosas positivas que le sucedieron durante la semana	30 min
• Finalizar la sesión y programar la segunda sesión	5 min

7.2. Sesión F1-B

F1- Satisfacción Personal

2ª Sesión | **Sesión F1- B**

Objetivos:

- Reforzar el sentido de la identidad
- Desarrollar el autoconcepto
- Promover la autoestima y el autoconcepto
- Promover la expresión de sentimientos
- Implementar la técnica del entrenamiento en autoinstrucciones

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Folios/1 cuaderno
- Bolígrafos

Procedimento:

• Saludos iniciales	5 min
• Verificación de la tarea de casa en la que cada profesional compartirá aquellas cosas positivas que le sucedieron durante la semana • Cada participante deberá escribir en un papel algún defecto /-s que le caracteriza	25 min
• Compartir con el grupo lo que escribió • Cada participante deberá escribir al lado del defecto/-s, alguna virtud/-es que le caracteriza • Compartir con el grupo lo que escribió • Se abre un espacio de discusión para compartir lo que sintieron al sustituir los defectos por las virtudes	25 min
• Programar la siguiente sesión y saludos finales	5 min

7.3. **Sesión F1-C**

F1- Satisfacción Personal

3ª Sesión | **Sesión F1- C**

Objetivos:

- Reforzar el sentido de identidad
- Desarrollar el autoconcepto
- Promover la autoestima y el autoconcepto
- Promover la expresión de sentimientos
- Implementar la estrategia de modelado

Material:

- Sala
- Sillas
- Sombrero
- Espejo pequeño

Procedimento:

• Saludos iniciales	5 min
• El dinamizador, previamente al inicio de la sesión, pega un espejo pequeño en el fondo de cada sombrero • El dinamizador explica que en cada sombrero se encuentra la fotografia de una persona. Cada participante deberá coger un sombrero y, sin divulgar quién aparece en la foto, tendrá que explicar al grupo si esa persona merece su respeto y consideración y explicar por qué. • Cada participante realiza este ejercicio, uno a uno, siempre fuera del ángulo de visión de los demás participantes, para que nadie pueda descubrir quién está en la foto • Se abre un espacio de discusión con todos los participantes para que verbalizen y expresen lo que sintieron al verse en el sombrero, después de haberse presentado como la persona más importante del mundo	30 min
• Saludos finales	15 min
• Programación de la próxima sesión	10 min

Nota:

Técnica de modelado: deriva de Bandura, en la que el aprendizaje se realiza observando la conducta de los demás teniendo en cuenta sus consecuencias (Loureiro, 2013). El individuo interviene de forma activa, pues además de observar y realizar la conducta, ésta debe ser reproducida según su interpretación personal acerca de la conducta a realizar.

8. SESIONES DEL FACTOR: F2- ACTITUD PROSOCIAL

8.1. Sesión F2-A

F2- Actitud prosocial

1ª Sesión | **Sesión F2- A**

Objetivos:

- Promover la autorrealización
- Desarrollar la motivación por la vida
- Desarrollar actitudes de ayuda para la comunidad
- Promover la expresión de sentimientos
- Implementar estratégias de reflexión

Material:

- Sala; Mesa; Sillas; Columnas; Mp3
- Música: *"Sentir"* Luz Casal
- Folios/ 1 cuaderno
- Bolígrafos

Procedimento:

• Saludos iniciales	10 min
• Colocar música sugestiva de Actitud prosocial "Sentir", Luz Casal • Reflexionar en grupo sobre lo que el mensaje de la música nos hace sentir • Anotar en un folio las cosas que quisieran cambiar en sus vidas en favor de los demás	20 min
• A continuación, cada participante presenta y comparte las cosas que les gustaría cambiar de sus vidas, en favor de los demás • Se abre un espacio de discusión entre todos los participantes para que puedan expresar las distintas emociones • Tarea para casa: solicitar que la persona escriba estratégias que pueda concretar para modificar los parámetros que les gustaría cambiar en sus vidas	30 min
• Programación de la próxima sesión y saludos finales	10 min

Nota:

La evidencia señala que las letras de canciones con contenido prosocial, es decir, como medio de comunicación y socialización con los demás, pueden tener un impacto relevante en la reducción de la agresión y variables relacionadas, así como en la motivación de las personas hacia conductas prosociales (Pimentel, 2015).

8.2. Sesión F2-B

F2- Actitud prosocial

2ª Sesión | **Sesión F2- B**

Objetivos:

- Estimular actitudes altruistas
- Reforzar la autorrealización
- Desarrollar actitudes de apoyo a la comunidad
- Facilitar la expresión de sentimientos
- Implementar estratégias de reflexión

Material:

- Sala; Mesa; Sillas;
- Globos
- Palillos de dientes
- Folios/ 1 cuaderno
- Bolígrafos

Procedimento:

• Saludos iniciales	
• Compartir la tarea de casa, en la que cada participante debe describir las estratégias que enumeró para cambiar los parámetros en sus vidas	5 min
• A continuación, se les pedirá a los participantes que escriban en un folio aquellas cosas que se les ocurre para ayudar a los demás (teniendo en cuenta la diversidad cultural, las diferencias entre las personas, etc...) en un plazo de 1 mes, 6 meses y 1 año	20 min
• Colocar el papel dentro de un globo e inflarlo • Después, con la ayuda de un palillo, van a intentar rebentar los globos de los otros participantes • Reflexionar sobre la actividad: por qué dejaron que sus ideas altruistas/de ayuda a los demás se *"esfumaran"* • Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para debatir/expresar que emociones sintieron cuando sus ideas altruistas se *"esfumaron"* • Reflexionar acerca de la importancia de ayudar a los demás, aún con diferencias existentes • Tarea para casa: pensar en la forma de concretar alguna acción de ayuda hacia los demás, en el plazo de 1 mes	30 Min
• Programar la siguiente sesión. Saludos finales	5 min

8.3. **Sesión F2-C**

F2- Actitud prosocial

3ª Sesión | **Sesión F2- C**

Objetivos:

- Reforzar las actitudes altruistas
- Desarrollar estratégias de apoyo a realidades distintas en nuestra comunidad
- Promover la expresión de sentimientos
- Implementar estratégias de reflexión

Material:

- Sala
- Sillas

Procedimento:

• Saludos iniciales	10 min
• Verificar/compartir la tarea de casa, en la que cada participante pensó en concretar alguna acción de ayuda a los demás, en el plazo de 1 mês	20 min
• Reflexionar sobre las acciones/conductas a modificar para ayudar a los demás (6 meses y 1 año) • Los demás participantes podrán ayudar/dar sugerencias	30 min
• Abierto un espacio de discusión entre todos • Programación de la próxima sesión y saludos finales	10 min

Nota:

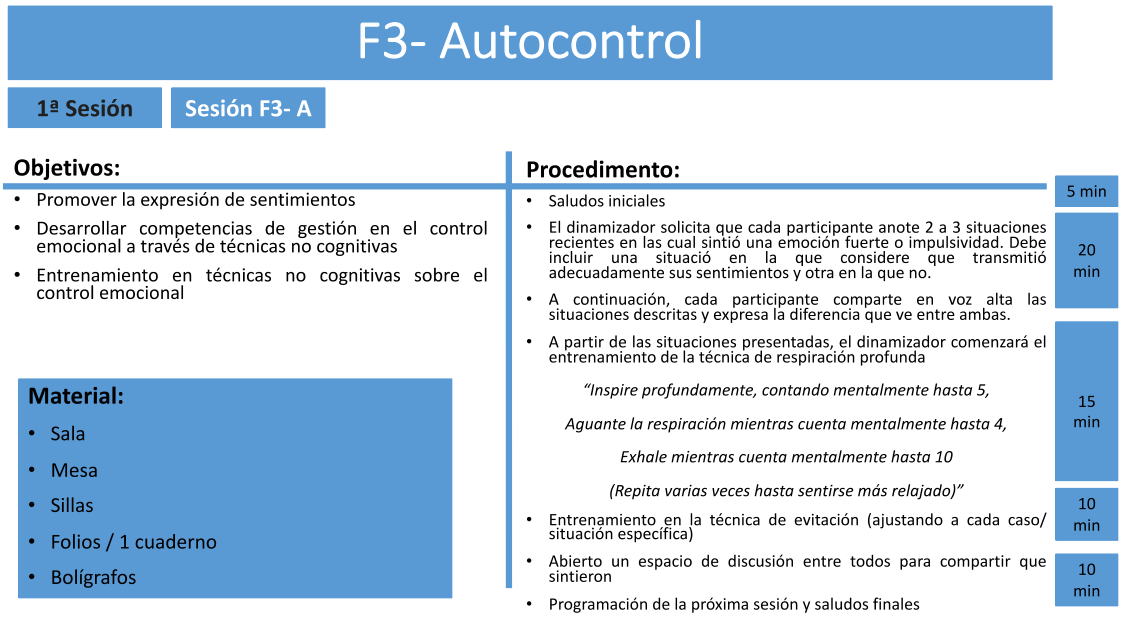
La estrategia de reflexión se presenta como el valor añadido de la reflexión sobre la acción, en tanto que constituye un componente facilitador del aprendizaje, considerando que cuando la reflexión se lleva a cabo intencionalmente conduce a la construcción del conocimiento. Cuando la reflexión está construida sobre un marco teórico y metodológico facilita el ejercicio de la autonomía de las personas (Santos, 2009).

Según Kim (1999), la conciencia personal y profesional se crea a partir del proceso de aprender a aprender y modificar en la práctica a través de la autocrítica y la conciencia de la toma de decisiones que se fortalecen con la reflexión, a partir de una descripción de situaciones.

Veilleux (1998) afirma que la reflexión ayuda a desenterrar lo aprendido para buscar nuevas vías, permitiendo diferenciar valores a los que hemos dado poca importancia, a los que están efectivamente en el origen de nuestras acciones.

9. SESIONES DEL FACTOR: F3-AUTOCONTROL

9.1. Sesión F3-A



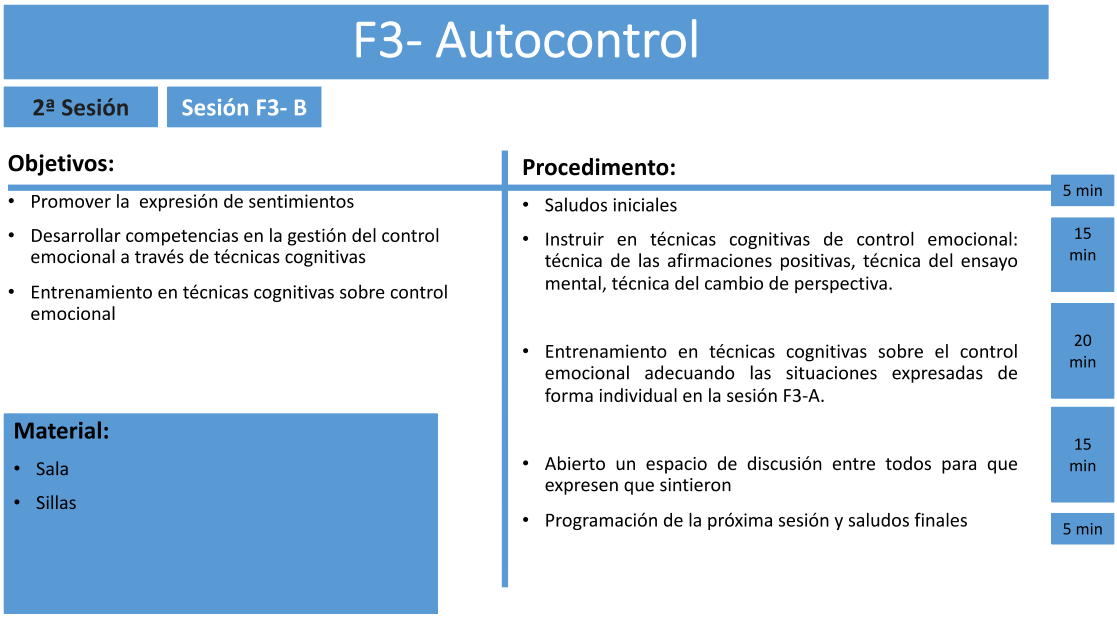
Nota:

Técnica de respiración profunda: "la relajación es una técnica accesible a todas las personas y ayuda a crear salud, a mejorar la mente y el cuerpo" (Marilda, 2008, p. 9). "Este ejercicio puede ser realizado en cualquier momento de tensión por todas las personas. No hay ninguna restricción. Es de acción rápida, se puede realizar en cualquier lugar, varias veces al día y tiene efecto/-s inmediatos" (Marilda, 2009, p. 17). La relajación mental permite la reflexión, la evaluación de los propios valores e ideas (Marilda, 2008, p. 9).

"Las técnicas de relajación tienen beneficios físicos y psicológicos e incluso beneficios terapéuticos. Ayudan a la persona a desarrollar la capacidad de afrontar, de forma más eficaz, los síntomas físicos que contribuyen a la ansiedad" (Elias, 2014).

Técnica de evitación: Kliewer (1991) nos dice que las estrategias de evitación centradas en las emociones pueden funcionar como adaptativas cuando la situación no se puede cambiar o cuando la situación evoca mucha emoción. La estrategia de evitación puede reflejar un intento de mantener el control sobre una situación determinada.

9.2. **Sesión F3-B**



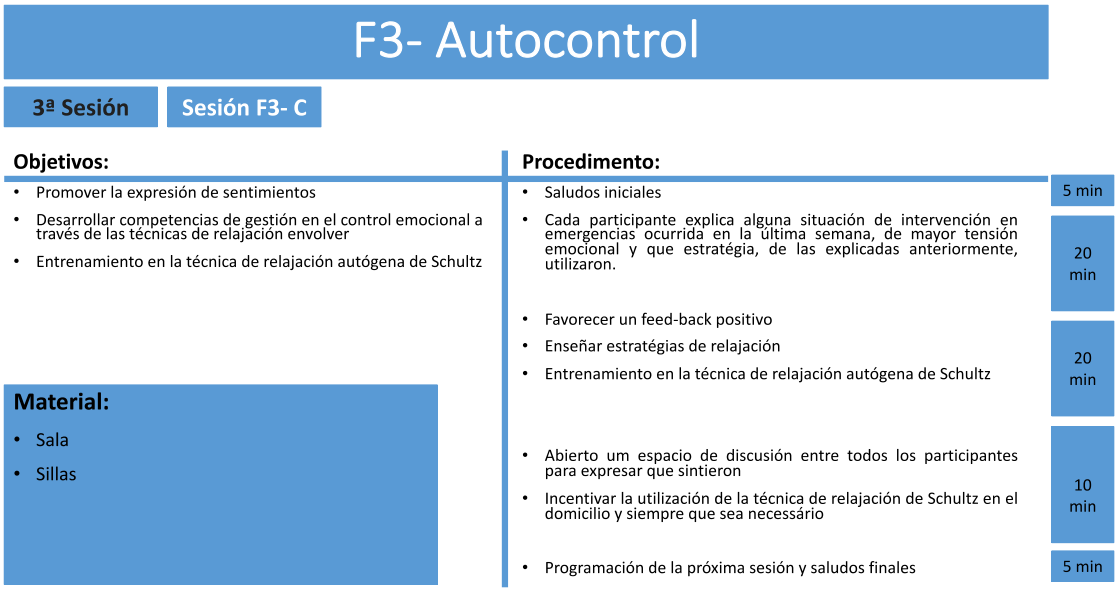
Nota:

Técnica de afirmación positiva: Souza (2015) nos dice que el principio básico es que si cambiamos nuestro pensamiento podemos regular nuestras emociones y acciones, porque la emoción y el pensamiento están íntimamente ligados. Las emociones no se pueden modificar, pero podemos identificar y cambiar los pensamientos negativos que están en la base, y así reemplazarlos por pensamientos más positivos.

Técnica de ensayo mental: consiste en visualizar una situación y practicarla mentalmente, lo que conllevará a un menor nivel de ansiedad proporcionando mayor confianza para superar la situación de manera efectiva (Souza, 2015).

Técnica de cambio de perspectiva: comprende ampliar el foco de la situación y/o ponerse en el lugar del otro (Souza, 2015).

9.3. **Sesión F3-C**



Nota:

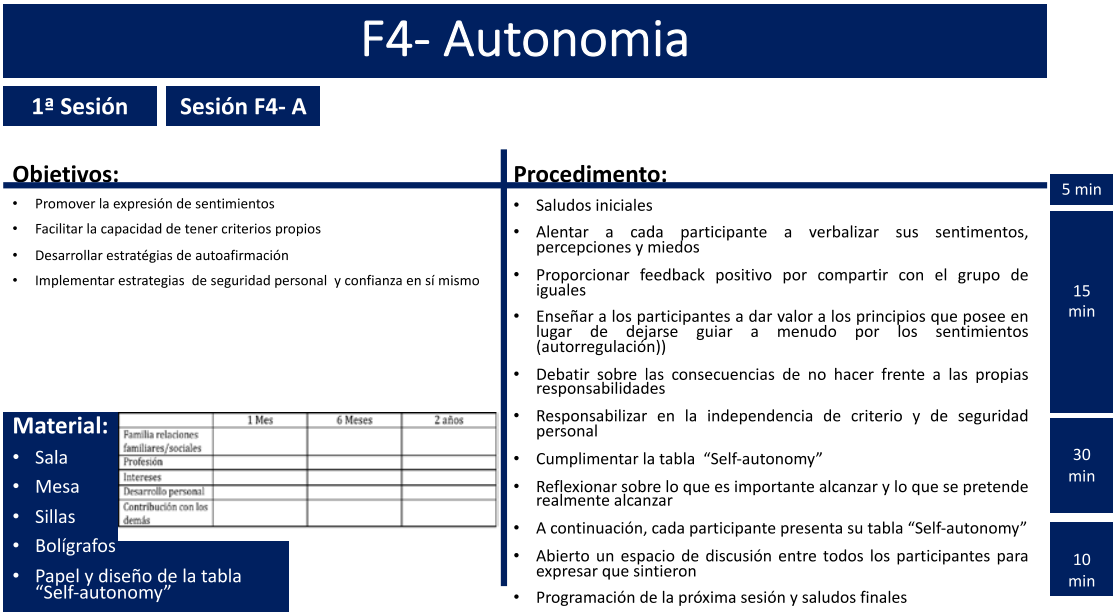
Técnica de relajación autógena de Schultz: "Consiste en inducir a la persona a una situación de tranquilidad psíquica a través de la respiración, reduciendo los estímulos externos y la concentración voluntaria y consciente hacia funciones sensoriales" (Schultz, 1967).

"Después de elegir la posición de relajación (recostado/sentado), cierro los ojos durante la sesión de relajación. Mentalmente se dice: mis brazos y piernas pesan agradablemente (repito 5-6 veces); Estoy perfectamente tranquilo y relajado (repito 1 vez); mis brazos y piernas están agradablemente calientes (repito 5-6 veces); Estoy perfectamente tranquilo y relajado (repito 1 vez); mi respiración es tranquila y equilibrada (repite 5-6 veces; estoy perfectamente tranquilo y relajado (repite 1); mi corazón late tranquilo y normal o mi pulso es tranquilo y normal (repite 5-6 veces); estoy perfectamente tranquilo y relajado (repetir 1 vez), mi plexo solar (vientre) está caliente (repetir 5-6 veces), estoy perfectamente tranquilo y relajado (repetir 1 vez), mi frente está agradablemente fresca (repetir 5-6 veces); Estoy perfectamente calmado y relajado (repito 1 vez), siento mis brazos firmemente, estiro mi cuerpo, respiro tranquila y profundamente y abro los ojos "(Schultz, 1967).

Técnicas alternativas de relajación: Técnica de relajación de Herbert Benson, cuenta números hacia atrás, control de la respiración durante 1 min, estiramiento de los dedos con una pelota antiestrés, escucha música tranquila, meditación, yoga, masajes corporales, imaginación, actividades al aire libre, etc.

10. SESIONES DEL FACTOR: F4-AUTONOMIA

10.1. **Sesión F4-A**



Nota:

Estrategia de autoafirmación: refleja un conjunto de conductas que emite una persona, en un contexto interpersonal, en el que expresa sus sentimientos, deseos y opiniones, o incluso sus derechos, de forma directa, segura y honesta, respetando los sentimientos, actitudes y derechos de los demás. También permite a la persona controlar la situación, negociar en base a objetivos específicos y claramente fijados, buscando compromisos realistas (Porto, 2012).

Tabla 6 – Diseñar y analizar

	1 Mes	6 Meses	2 años
Familia relaciones familiares/sociales			
Profesión			
Intereses			
Desarrollo personal			
Contribución con los demás			

10.2. **Sesión F4-B**

F4- Autonomia

2ª Sesión | **Sesión F4- B**

Objetivos:

- Promover la expresión de sentimientos
- Facilitar la creación de toma de decisiones
- Desarrollar la confianza en sí mismo
- Implementar la estratégia de autorreflexión

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Bolígrafo
- Papel
- Cartel de análisis DAFO:Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades



Procedimento:

• Saludos iniciales	5 min
• Preguntar a los participantes sobre qué es la autoconfianza • Abierto un espacio de discusión sobre la autoconfianza • Ejecutar técnica de análisis DAFO (cada participante piensa en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)	15 min
• Cada participante verbaliza en grupo su análisis • Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para expresar que sintieron	30 min
• Programación de la próxima sesión y saludos finales	10 min

Notas:

Análisis FODA: diseñado por Kenneth Andrews y Roland Cristensen, profesores de Harvard Business School. La matriz de análisis FODA estudia la competitividad de una organización de acuerdo a cuatro variables: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. A través de estas cuatro variables, será posible enumerar las fortalezas y debilidades de la empresa/persona, de las oportunidades y amenazas del entorno en el que opera la empresa y/o se desarrolla la persona (Rodrigues, et al., 2005).

La matriz de análisis FODA es una herramienta que se utiliza para realizar análisis de escenarios (o análisis ambiental), siendo utilizada como soporte para la gestión y planificación estratégica (Daychouw, 2007).



Fig. 6 – Matriz de análisis FODA. Fuente: adaptado Paulillo,2020.

10.3. **Sesión F4-C**

F4- Autonomia

3ª Sesión | **Sesión F4- C**

Objetivos:

- Reforzar la autoconfianza
- Promover la expresión de sentimentos
- Implementar la estrategia de la autorreflexión

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Bolígrafo
- Papel

Procedimento:

• Saludos iniciales	5 min
• El dinamizador solicita a cada participante que piense en 5 cosas de su vida que ha logrado o alcanzado y que las registre • A continuación, cada participante lee en voz alta su lista • El dinamizador sugiere que cada participante guarde su lista para consultarla siempre que ponga en duda alguna de sus capacidades	35 min
• Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para compartir y expresar que sintieron	15 min
• Programación de la próxima sesión y saludos finales	5 min

11. SESIONES DEL FACTOR: F5- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AUTOACTUALIZACIÓN

11.1. **Sesión F5-A**

F5- Resolución de problemas y autoactualización

1ª Sesión | **Sesión F5- A**

Objetivos:

- Desarrollar la percepción objetiva
- Desarrollar estrategias de resolución de problemas

Material:

- Sala
- Sillas
- Papel/1 cuaderno
- Alicates
- Papel
- Pegamento

Procedimento:

• Saludos iniciales	5 min
• Implementar el ejercicio de los dos hilos de Maier (Thomas & Lleras, 2009):	
Se invita a que cada participante sea capaz de unir los dos hilos previamente separados en dos puntas de la sala. Para ello tendrán disponible el siguiente material: alicates, sillas, papel, pegamento, etc,. La conclusión parece obvia pero no lo es: será necesario que los participantes abran los brazos para conseguir unirse y acercar los hilos, concectándose a través de las manos. Al final, encuentran la solución más inteligente, a veces, sin hacer uso del material disponible.	15 min
• El dinamizador solicita que cada participante piense en una situación de su trabajo cotidiano, que deberá resolver y/o que le preocupa	
• A continuación, el dinamizador sugiere que piensen una estrategia para resolver la situación anterior	
• Cada participante comparte en voz alta con el grupo la situación en la que pensó y la estratégia para resolverla	35 min
• Se inicia un espacio de discusión en el que cada participante expone su situación/estrategia y se opina sobre posibles sugerencias para la resolución del problema en cuestión	
• Tarea para casa: mobilizar los recursos físicos y mentales disponibles para resolver el problema y supervisar el progreso	
• Programación de la proxima sesión y saludos finales	5 min

Nota:

Estrategia de resolución de problemas: para resolver un problema, existen pasos o ciclos que se pueden realizar. Sin embargo, no hay consenso entre los investigadores. En la literatura se describen varias secuencias posibles (Neto, 1998), como la que presentamos aquí. Si al llegar al último paso el problema persiste, es necesario volver al inicio del proceso.

11.2. **Sesión F5-B**

F5- Resolución de problemas y autoactualización

2ª Sesión | **Sesión F5- B**

Objetivos:

- Mejoras estratégias de adaptación al cambio
- Reforzar estratégias de resolución de problemas
- Promover la expresión de sentimientos

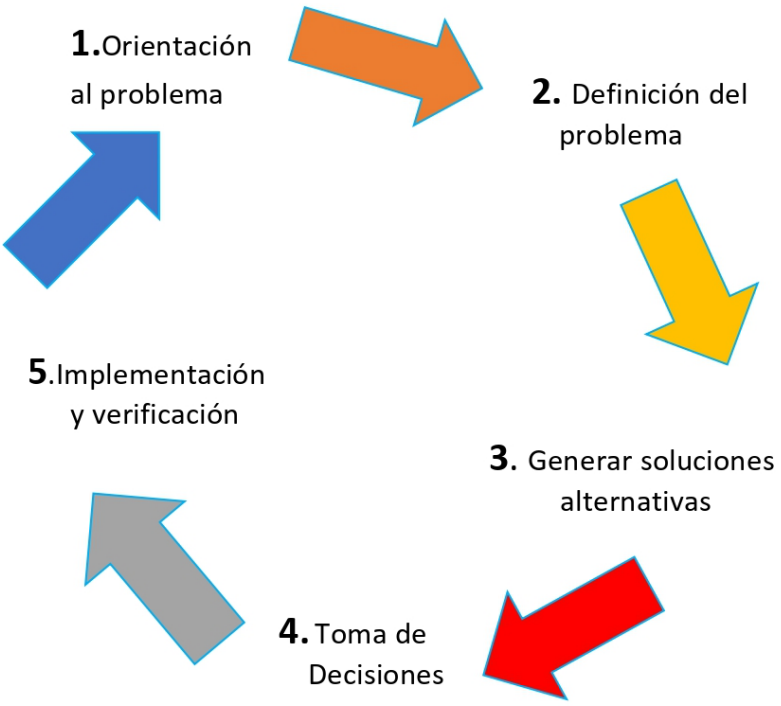


Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Rueda de resolución de problemas

Procedimento:

- Saludos iniciales — 5 min
- Verificación de la tarea de casa, en la que cada participante verbaliza cómo mobilizó los recursos físicos y mentales para la resolución de su problema/-s
- Reflexionar sobre los progresos alcanzados
- Evaluar en grupo si la estratégia utilizada es adecuada. Todos los participantes podrán opinar y dar sugerencias al respecto — 30 min
- Después de recibir/dar todas las opiniones, el dinamizador pone de manifiesto que si el problema aun persiste, puede ser necesario volver a etapas anteriores y hacer una reevaluación de la situación/problema
- El dinamizador presenta la imagen de la rueda de resolución de problemas impresa en tamaño Din-A3
- Incentivar a los participantes a utilizar la rueda de resolución de problemas propuesta
- Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para compartir y expresar que sintieron — 20 min
- El dinamizador concluye que cada problema es único y que la resolución está en cada uno
- Programación de la próxima sesión y saludos finales — 5 min



11.3. **Sesión F5-C**

F5- Resolución de problemas y autoactualización

3ª Sesión | **Sesión F5- C**

Objetivos:

- Reforzar la percepción objetiva
- Promover la expresión de sentimientos
- Implementar estratégia de autorreflexión

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas

Procedimento:

- Saludos iniciales — 5 min
- El dinamizador propone a cada participante oralmente terminar a frase:
- "Yo pienso…" o "Yo quiero…"
- Depues de que todos los participantes hayan terminado la frase, el dinamizador propone una nueva ronda para que, nuevamente, todos los participantes completen la frase: "Yo consigo..." — 35 min
- Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para compartir y expresar qué sintieron
- El dinamizador concluye que cada respuesta está en cada uno — 15 min
- Programación de la próxima sesión y saludos finales — 5 min

12. SESIONES DEL FACTOR: F6- HABILIDADES DE RELACIÓN INTERPERSONAL

12.1. **Sesión F6-A**

F6- Habilidades de relación interpersonal

1ª Sesión | **Sesión F6- A**

Objetivos:

- Mejorar la adecuación de las relaciones interpersonales
- Promover la expresión de sentimientos
- Desarrollar estratégias de adecuación de las necesidades individuales a la realidad
- Implementar estratégias de autorreflexión

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Bolígrafos
- Folios/1 cuaderno
- Caja con apertura o "Caja de las Relaciones"

Procedimento:

- Saludos iniciales — 5 min
- Implementar el ejercicio de la "Caja de las Relaciones":

  Se invita a que cada participante escriba detalladamente sus dificultades en el ejercicio profesional (problemas, quejas...) de forma anónima. Dobla el papel y lo introduce en la Caja de las Relaciones. Es importante que las dificultades no sean de tipo material, sino de naturaleza emocional y de relaciones interpersonales

- El dinamizador solicita que cada participante coja un papel de la Caja y lo comparta en voz alta con el grupo. Se informa que no se pretende identificar de quién es el papel.
- A continuación, despues de que el participante lee el papel, el resto del grupo sugiere soluciones individualmente, y así sucesivamente, hasta que todos los participantes hayan leído un papel. — 40 min
- Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para compartir y expresar qué sintieron — 10 min
- Programación de la próxima sesión y saludos finales — 5 min

12.2. **Sesión F6-B**

F6- Habilidades de relación interpersonal

2ª Sesión **Sesión F6- B**

Objetivos:

- Promover relaciones gratificantes
- Promover la expresión de sentimientos
- Implementar estratégias de autorreflexión

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Hojas de papel con preguntas impresas

Procedimento:

- Saludos iniciales — 5 min
- El dinamizador reparte a los participantes una serie de preguntas impresas para invitar a la reflexión: — 40 min

¿Como reacciona cuando en su trabajo alguién pierde la calma hasta ponerse violento?
En situaciones de alto contenido emcional /tensas, ¿como suele reaccionar?
¿Qué situaciones recuerda que lo dejen completamente "fuera de si"?
¿Qué situaciones sucedidas con otras presonas le hicieron realmente sufrir?
Las situaciones que me dejan profundamente abatido son las que.....;
Te ha sucedido , a menudo, que al no saber decir "no", ¿hiciste cosas que no querías hacer?
¿Se siente Vd. una persona afortunda/querida en el trabajo? ¿Porqué?
¿Cuál es su nivel de tolerancia (alto/medio/bajo) a la hora de aceptar afirmaciones negativas, sobre sus emociones?
Cuando debo tomar una decisión importante, siento que .....;
¿Me considero un profesional que, sin ayuda, soy capaz de encontrar razones suficientes para saber que es lo que debo hacer?

- A continuación, el dinamizador solicita a cada participante que seleccione una de las preguntas expuestas anteriormente y exponga su respuesta al resto del grupo .
- Señalar que los participantes pueden escoger preguntas que otros participantes hayan elegido también.
- Repetir el procedimento anterior tantas veces como sea necesario
- Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para compartir y reflexionar sobre qué sintieron. — 15 min
- Tarea de casa: cada participante deberá hacer una lista de las "10 cosas que podrían suceder si no trabajo mis relaciones interpersonales" — 5 min
- Programación de la próxima sesión y saludos finales.

12.3. **Sesión F6-C**

F6- Habilidades de relación interpersonal

3ª Sesión **Sesión F6- C**

Objetivos:

- Promover las relaciones gratificantes
- Reforzar estratégias de adecuación de las necesidades individuales a la realidad
- Promover la expresión de sentimientos

Material:

- Sala
- Mesa
- Sillas
- Piedras con palabras escritas en la parte superior

Procedimento:

- Saludos iniciales — 5 min
- Verificación de la tarea de casa, en la que cada participante verbaliza y comparte la lista de "10 cosas que podrían suceder si no trabajo mis relaciones interpersonales" — 20 min
- El dinamizador presenta las "Piedras Angulares de las Relaciones Laborales". En las piedras hay escrito uno de los valores esenciales para las relaciones: Confianza, colaboración, empatia, autoconocimiento, escucha, aceptación de las diferencias y respeto.
- A continuación, el dinamizador solicita a cada participante que seleccione una piedra angular de las relaciones laborales y explique el motivo de la elección — 30 min
- Abierto un espacio de discusión entre todos los participantes para compartir y expresar qué sintieron.
- Programación de la próxima sesión y saludos finales — 5 min

13. SESIÓN FINAL

Sesión Final (Individual)

Objetivos:	Procedimento:	
• Evaluar la SM+ • Feedback sobre el programa de SM+ • Cierre del programa de SM+	• Saludos iniciales	5 min
	• Evaluación final de los participantes a través del cuestionario de datos sociodemográficos • Administrar el cuestionario de SM+ • Agradecer la participación	25 min
Material: • Sala • Mesa • Sillas • Bolígrafos • Cuestionario de datos sociodemográficos • Cuestionario de SM+	• Recoger las opiniones/impresiones sobre el programa de SM+ • Orientación para el seguimiento • Cierre del programa • Animar a los participantes si fuera necesario, para seguir formandose en el autocuidado, a través del programa de SM+	25 min
	• Saludos finales	5 min

14. SESIÓN DE SEGUIMIENTO

Seguimiento (Individual)

Objetivos:	Procedimento:	
• Evaluar la SM+ 3 meses después de la implementación del programa de SM+	• Evaluación de los participantes a través del cuestionario de datos sociodemográficos • Administrar el cuestionario de SM+	20 min
Material: • Sala • Mesa • Sillas • Bolígrafos • Cuestionario de datos sociodemográficos • Cuestionario de SM+	• Resolución de dudas	10 min

BIBLIOGRAFIA

Alarcón M, Barradas J, Ibañez M, Trapaga J. (2011). Factores de salud mental positiva en estudiantes de psicología universidad veracruzana. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 1(2), 123-135.

Daychouw, M. 40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento. 3 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

Elias, M. (2014). As técnicas de relaxamento como instrumento terapêutico de enfermagem em pessoas com sofrimento mental, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Portugal.

Garcia, I. R. (2016). Saúde mental positiva em adolescentes (Tese Mestrado, Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal). Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/17844/1/Dissertac%CC%A7a%CC%83o_definitiva_IRENE%20ROURA%20%281%29.pdf

Hurtado, B., Lluch, M., Casas, I., Sequeira, C., Puig, M., & i Roldan, JF. (2018). Evaluación de la fiabilidad y validez del cuestionario de salud mental positiva en profesores universitarios de enfermería en Cataluña. *Revista Enfermería y Salud Mental*, 9, 5-17.

Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books

Keyes C. L. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: a complementary strategy for improving national mental health. *American Psychologist*, 62(2), 95-108.

Kim, H. (1999). Critical reflective inquiry for Knowledge development in nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 29(5), 1205 -1212.

Kliewer, W. (1991). Coping in middle childhhod: Relations to competence, type A behavior, monitoring, blunting, and locus of control. *Developmental Psychology*, 27, 689-697.

Lluch-Canut M.T. (1999). Construccion de una escala para evaluar la salud mental positiva. (Doctoral Thesis, Department of Behavioral Sciences Methodology: Universidade de Barcelona, Espanha). Disponível em: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/42359/1/E_TESIS.pdf

Lluch, M. T. (2002). Evaluación empírica de un modelo conceptual de salud mental positiva. *Salud Mental*, 25(4), 42-55.

Lluch, M.T. (2003). Construcción y análisis psicométrico de un cuestionario para evaluar la salud mental positiva. Psicología Conductual. *Revista internacional de psicología clínica y de la salud*, 11(1) 61-78

Lluch, M. T. (2008). *Concepto de salud mental positiva: Factores relacionados*. In J. Fornes, y J. Gómez (coord.), Recursos y programas para la salud mental. Enfermería psicosocial II (pp. 37-69). Madrid: Fuden, Colección líneas de especialización en enfermería.

Lluch, Mª T. (2011). Decalogue of Positive Mental Health/ Decálogo de Salud Mental Positiva/ Decàleg de Salut Mental Positiva. Barcelona: Colección OMADO Deposito Digital Universidade de Barcelona. Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/20062/11/Decalogo_Salud_Mental_Positiva_trilingue.pdf

Lluch, M.T. (2020). *Cuida la Salud Mental Positiva: un abordaje para afrontar con más fuerza mental la situación generada por la pandemia de Coronavirus Covid-19*. Barcelona: Depósito Digital da Universitat de Barcelona. Disponível em: http://hdl.handle.net/2445/155397

Lluch-Canut, M.T.; Sequeira, C.; Roldán-Merino, J.F. (2017). La salud mental positiva desde una perspectiva multifactorial. En V. Fragoso y M. Sotto Mayor (Coords.), *Gerontologia e transdisciplinariedade I* (pp. 114-129). São Paulo (Brasil): Portal Edições Envelhecimento.

Lluch-Canut, T., Puig-Llobet, M., Sánchez-Ortega, A., Roldán-Merino, J., & Ferré-Grau, C. (2013). Assessing positive mental health in people with chronic physical health problems: correlations with socio-demographic variables and physical health status. *BMC Public Health*, 13(1). doi:10.1186/1471-2458-13-928

Loureiro, C. (2013). Treino de Competência Sociais – Uma estratégia em saúde mental: técnica e procedimentos para a intervenção*. Revista Portuguesa de Saúde mental*, 9, 41-47.

Mantas-Jiménez, S., Juvinyà i Canal, D., Bertran i Noguer, C., Roldán-Merino, J., Sequeira, C., & Lluch Canut, M. (2015). Evaluation of positive mental health and sense of coherence in mental health professionals. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental* (13), 34-42.

Marilda, E. (2008). Relaxamento para todos: controle o seu stress. Novaes Lipp. Campinas, SP: Papirus.

Michael W. E., Mark T. K. (2017). Manual de psicologia cognitiva. 7 ed. Artmed Editora.

Neto, A. J. (1998) Resolução de problemas em Física. Lisboa. Instituto de Inovação Educacional.

Paulillo, G. (2020, março 09). Matriz SWOT: como fazer a análise estratégica de sua empresa. Disponível em: https://www.agendor.com.br/blog/matriz-swot-como-fazer/

Pimentel, C. (2015). Efeitos de letras de músicas em comportamentos pró-sociais: Teste do Modelo Geral da Aprendizagem, Universidade Federal da Paraíba. Brazil.

Porto, M. (2012, maio 30). Auto-afirmar-se para comunicar eficazmente. Disponível em: https://oficinadepsicologia.blogs.sapo.pt/141936.html.

Programa Nacional para a Saúde Mental (2014). Portugal-Saúde Mental em Números-2014. Lisboa: Governo de Portugal. Ministério da Saúde Disponível em: www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/portugal-saude-mental-em-numeros-2014.aspx

Rodrigues, J. N.; et al. 50 Gurus Para o Século XXI. 1. ed. Lisboa: Centro Atlântico.PT, 2005.

Roldán-Merino, J., Lluch-Canut, M. T., Casas, I., Sanromà-Ortíz, M., Ferré-Grau, C., Sequeira, C., … Puig-Llobet, M. (2017). Reliability and validity of the Positive Mental Health Questionnaire in a sample of Spanish university students. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 24(2-3), 123–133. doi:10.1111/jpm.12358

Santos, E. (2009). A aprendizagem pela reflexão em ensaio clínico. Estudo qualitativo na formação inicial em enfermagem, Universidade de Aveiro, Portugal.

Schultz, J. H. Auto-reflexão concentrativa/ exposição clínico-prática. São Paulo: Mestre Jou, 1967.

Sequeira C., Carvalho, J., Sampaio, F., Sá, L., Canut-Lluch T., & Roldán-Merino J. (2014). Avaliação das propriedades psicométricas do questionário de saúde mental positiva em estudantes portugueses do ensino superior. *Revista Portuguesa de Saúde Mental*, 11, 45-53.

Sequeira, C. & Carvalho, J.C. (2009). Tradução para a População Portuguesa do Questionário de Saúde Mental Positiva (QSM+). Saúde e Qualidade de Vida em análise, 303-314. Porto: Escola Superior de Enfermagem do Porto. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/32000/1/2009_Saúde e Qualidade de Vida em Análise303-314.pdf

Sequeira, C.; Carvalho, J.C.; Gonçalves, A.; Nogueira, M.J.; Lluch-Canut, T.; Roldán-Merino, J. (2019 online) Levels of Positive Mental Health in Portuguese and Spanish Nursing Students. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1078390319851569

Sequeira, C.; Lluch, T. (2015). Saúde Mental Positiva - Conferência apresentada no Dia Mundial da Saúde Mental na Escola Superior de Saúde de Viseu. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/282663073_Saude_Mental_Positiva

Souza, T. (2015, maio 25). Técnicas de Controle Emocional. Fobias. Disponível em: https://psiconlinews.com/2015/05/tecnicas-de-controle-emocional.html

Teixeira, S. M. A., Coelho, J. C. F., Sequeira, C. A. da C., Lluch i Canut, M. T., & Ferré-Grau, C. (2019). The effectiveness of positive mental health programs in adults: A systematic review. *Health & Social Care in the Community,* 00, 1–9. doi:10.1111/hsc.12776

Teixeira, S.; Sequeira C.; Ferré-Grau C., Lluch I Canut M. Characteristics of a Positive Mental Health Program for adults: a Focus Group study (na imprensa)

Veilleux, M. (1998). La voix de láspiration: retrouver ses repères pour redonner un sens au quotidien des soins infirmiers. In: IVe Colloque du Réseau PRAQSI – Actes, (1997), Le soin infirmier une force de vie au quotidian. Lisboa: Réseau PRAQSI. Pp. 31-52.

World Health Organization (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice: summary report. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. Prevention of Mental Disorders – Effective interventions and policy options. Geneva: World Health Organization; 2001.

Xavier, M., Baptista, H., Mendes, J. M., Magalhães, P., & Caldas-de-Almeida, J. M. (2013). Implementing the World Mental Health Survey Initiative in Portugal – rationale, design and fieldwork procedures. *International Journal of Mental Health Systems*, 7(1), 19. doi:10.1186/1752-4458-7-19

Anexos



Anexo I

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del estudio: Programa de promoción de la Salud Mental Positiva en adultos (Mentis Plus^{+}): manual de apoyo.

Explicación del estudio: Si acepta participar en este estudio, inicialmente se le pedirá que responda un cuestionario, donde se le harán preguntas sobre el tema en cuestión.

El programa tiene una duración mínima de 7 semanas (1 sesión por semana, con una duración de 1 hora). Habrá 2 sesiones iniciales de 1 hora cada una. Consta 3 sesiones (A, B, C) para que cada factor/dimensión funcione, con una duración de al menos 1 hora. Habrá una sesión final y una sesión de seguimiento (3-6 meses después del programa) donde volverá a completar un cuestionario. El programa se puede trabajar individualmente o en grupos (6 - 12 personas como máximo). Su construcción fue el resultado de una revisión sistemática de la literatura sobre el tema, realizada en 2017.

El objetivo principal de este estudio es la aplicación de un programa de salud mental para promover la salud mental positiva en la población española.

Condiciones y financiación: Este estudio tiene un carácter voluntario de participación y no presenta ningún tipo de financiación. No hay riesgos para los participantes del estudio. No se esperan beneficios inmediatos, excepto la mejora y / o mantenimiento de la salud mental positiva para cada participante.

Confidencialidad y anonimato: Se mantendrá la confidencialidad de todos los datos relacionados con este estudio. En cualquier documento o publicación que se pueda originar, se excluirá cualquier información que pueda conducir a la identificación de los participantes. Al finalizar el estudio, se eliminarán todos los datos relacionados con las partes interesadas y que puedan conducir a su identificación. Esperamos que este estudio se complete para diciembre de 2020. Si desea conocer los resultados del estudio, puede solicitar a Susana Mantas a partir de esta fecha enviando un correo electrónico a: susana.mantas@udg.edu o por teléfono 630386872.

Firma/-s: ... ...

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Declaro haber leído y entendido este documento, así como la información verbal que me proporcionaron las personas que firmaron anteriormente. Se me garantizó la posibilidad, en cualquier momento, de negarme a participar en este estudio sin ninguna consecuencia. De esta manera, acepto participar en este estudio y permitir el uso de los datos que proporciono voluntariamente, confiando en que solo se utilizarán para esta investigación y en las garantías de confidencialidad y anonimato que me da el investigador.

Nombre: ... ...

Firma: .... Fecha: ..... / ..... / .....

ESTE DOCUMENTO SE COMPONE DE ... PÁGINA / S Y SE HACE EN DUPLICADO: UNA COPIA PARA EL INVESTIGADOR/-A, OTRA COPIA PARA LA PERSONA QUE PARTICIPA

Declaración de Helsinki: http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/Declaracion_Helsinki_Brasil.pdf

Anexo II

Formulario de datos socio demográficos

1-Edad: ☐☐

2- Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐

3-Estado Civil: Soltero/-a ☐ Casado-a/Pareja de hecho ☐ Divorciado-a/Separado-a ☐ Viudo/ ☐

4-Formación académica:

Educación Básica 1er ciclo	Educación Básica 2/3er ciclo	Educación Secundaria	Licenciatura	Postgrado	Doctorado
○	○	○	○	○	○

5-Institución, tipo de contrato y categoria professional en el lugar de trabajo:

Fijo ○ Eventual ○ Otro ○

5.1.- Institución: _____

5.2.- Categoria profesional: _____

6- ¿Vive desplazado de su residencia habitual? Si ☐ No ☐

7-Número de años de experiencia profesional: ☐☐

8-En el último año, ¿faltó al trabajo? Si ☐ No ☐

9-Número de horas de trabajo/semana: ☐☐

Historia de Salud Mental

10- ¿Tiene algún problema de Salud Mental? Sí ☐ No ☐

En caso de respuesta afirmativa, indique cuál: _____

11- En los últimos 3 meses, ¿acudió a algún servicio de salud a causa de un problema de salud mental?

Sí ☐ No ☐

12- ¿Ha recibido tratamiento psicológico o psiquiátrico? Sí ☐ No ☐

13- ¿Tiene familiares con problemas de Salud Mental? Sí ☐ No ☐

En caso de respuesta afirmativa, indique cuál: _____

Comportamientos de Salud durante el último mes

14- En relación a la necesidad de dormir, ¿está satisfecho con la calidad de su sueño? Sí ☐ No ☐

15- ¿Considera que duerme el número de horas suficientes de acuerdo con sus necesidades?

Sí ☐ No ☐

16- Indique el número medio de horas que duerme al día: ☐☐

17- ¿Toma algún medicamento para dormir? Sí ☐ No ☐

18- ¿Toma medicación de forma regular para algún problema de Salud Mental? Sí ☐ No ☐

19- ¿Practica algún deporte o ejercicio físico de forma regular? Sí ☐ No ☐

19.1.- Modalidad**:** _____

19.2.-Número medio de horas por semana: ☐☐

20- ¿Considera que su alimentación es saludable? Sí ☐ No ☐

21- Indique el numero medio de comidas que realiza al día: ☐☐

22- ¿Ingiere diariamente fruta/legumbres? Sí ☐ No ☐

23- ¿Con qué regularidad visita a sus familiares/amigos fuera del lugar de trabajo/escuela?

Más de 3 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	1 vez por semana	De 1 a 2 veces al mes	Raramente o nunca
◯	◯	◯	◯	◯

24- ¿Participa en alguna actividad recreativa? Sí No

En caso afirmativo, indique cuál: _____☐_____☐_____

25- ¿Tiene alguna relación afectiva significativa? Sí ☐ No ☐

En caso afirmativo:

Familia	Amigos íntimos/relación afectiva	Amigos	Otro
◯	◯	◯	◯

26- ¿Se encuentra satisfecho/-a con su vida afectiva? Sí ☐ No ☐

Sustancias Psicoactivas

27- ¿Consume bebidas alcohólicas? Sí ☐ No ☐

Más de 3 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	1 vez por semana	1 vez o 2 veces al mes
◯	◯	◯	◯

28- ¿Fuma cigarrillos? Sí ☐ No ☐

En caso afirmativo, número medio de cigarrillos al dia: ☐☐

29- ¿Consume drogas (haixís, heroína, cocaína, LSD) u otras? Sí ☐ No ☐

En caso afirmativo:

Más de 3 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	1 vez por semana	1 vez o 2 veces al mes
◯	◯	◯	◯

Anexo III – Cuestionario de Salud Mental Positiva (Lluch, 1999)*

Le presentamos un cuestionario que contiene una serie de afirmaciones referidas a la forma de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada uno de nosotros. Para contestarlo, lea cada frase y complete mentalmente el espacio de puntos suspensivos con la frecuencia que mejor se adapte a usted. A continuación señale con una X en las casillas de la derecha su respuesta.

Las posibles respuestas son:

- SIEMPRE o CASI SIEMPRE
- A MENUDO o CON BASTANTE FRECUENCIA
- ALGUNAS VECES
- NUNCA o CASI NUNCA

No necesita reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e incorrectas. Lo que interesa es su opinión. Tampoco trate de buscar la respuesta que quizá podría causar una "mejor impresión" ya que puede estar segura/o que la información es absolutamente anónima y confidencial.

POR FAVOR, CONTESTE A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS.

	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	CON BASTANTE FRECUENCIA	ALGUNAS VECES	NUNCA O CASI NUNCA
1 A mi, ... me resulta especialmente difícil aceptar a los otros cuando tienen actitudes distintas a las mías				
2 Los problemas .... me bloquean fácilmente				
3 A mi, ... me resulta especialmente difícil escuchar a las personas que me cuentan sus problemas				
4 .... me gusto como soy				
5 .... soy capaz de controlarme cuando experimento emociones negativas				
6 .... me siento a punto de explotar				
7 Para mi, la vida es .... aburrida y monótona				
8 A mi, ... me resulta especialmente difícil dar apoyo emocional				
9 .... tengo dificultades para establecer relaciones interpersonales profundas y satisfactorias con algunas personas				
10 .... me preocupa mucho lo que los demás piensan de mi				
11 Creo que .... tengo mucha capacidad para ponerme en el lugar de los demás y comprender sus respuestas				
12 .... veo mi futuro con pesimismo				
13 Las opiniones de los demás .... me influyen mucho a la hora de tomar mis decisiones				
14 .... me considero una persona menos importante que el resto de personas que me rodean				
15 .... soy capaz de tomar decisiones por mi misma/o				

16 .... intento sacar los aspectos positivos de las cosas malas que me suceden				
17 .... intento mejorar como persona				
18 .... me considero "un/a buen/a psicólogo/a"				
19 .... me preocupa que la gente me critique				
20 .... creo que soy una persona sociable				

21 .... soy capaz de controlarme cuando tengo pensamientos negativos				
22 .... soy capaz de mantener un buen nivel de autocontrol en las situaciones conflictivas de mi vida				
23.... pienso que soy una persona digna de confianza				
24 A mi, ... me resulta especialmente difícil entender los sentimientos de los demás				
25 .... pienso en las necesidades de los demás				
26 Si estoy viviendo presiones exteriores desfavorables .... soy capaz de continuar manteniendo mi equilibrio personal				
27 Cuando hay cambios en mi entorno .... intento adaptarme				
28 Delante de un problema .... soy capaz de solicitar información				
29 Los cambios que ocurren en mi rutina habitual .... me estimulan				
30 .... tengo dificultades para relacionarme abiertamente con mis profesores/jefes				
31 .... creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada				
32 .... trato de desarrollar y potenciar mis buenas aptitudes				
33 .... me resulta difícil tener opiniones personales				
34 Cuando tengo que tomar decisiones importantes .... me siento muy insegura/o				
35 .... soy capaz de decir no cuando quiero decir no				
36 Cuando se me plantea un problema .... intento buscar posibles soluciones				
37 .... me gusta ayudar a los demás				
38 .... me siento insatisfecha/o conmigo misma/o				
39 .... me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico				

*** Lluch MT.** Construcción de una escala para evaluar la salud mental positiva. Doctoral Thesis. University of Barcelona, 1999. http://tdx.cat/handle/10803/2366